

膀胱过度活动症 (OAB)

WARWIKI

患者须知 · 了解突然尿急、频繁如厕和漏尿

膀胱过度活动症（OAB）是一种常见且可治疗的疾病，表现为膀胱肌肉在不应收缩时发生收缩，引起突然而强烈的尿急感、如厕次数增多、夜间起床排尿，有时甚至在到达厕所前就发生漏尿。这并非衰老的正常现象，有多种方法可以改善症状。

关于这种疾病

正常情况下，膀胱平稳充盈，待到一定程度才发出排尿信号。OAB患者的膀胱会过早或过强地发出“急迫”信号。主要症状包括：

- **尿急** — 突然出现难以控制的排尿需求
- **尿频** — 每天排尿超过约8次
- **夜尿** — 夜间起床排尿
- **急迫性漏尿** — 赶往厕所途中发生漏尿

病因

通常没有单一原因——主要是膀胱与大脑之间信号传导异常。可能诱发或加重症状的因素包括：**咖啡因和酒精**、便秘、超重、某些药物，以及（女性）更年期。尿路感染也可引起相同症状，因此需首先排除感染。部分患者与神经系统疾病有关。

名词解释

膀胱过度活动症（OAB）

因膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

尿急

突然出现强烈的排尿感，难以延迟。

尿频

白天需要多次排尿。

夜尿

因需要排尿而从睡眠中醒来。

急迫性尿失禁

伴随强烈尿急感发生的漏尿。

膀胱日记

记录饮水量、如厕次数和漏尿情况的简单日志。

盆底

可通过锻炼来帮助控制膀胱的肌肉群。

膀胱训练

逐步延长如厕间隔时间，以减轻尿急症状。

会好转吗？ 会的——大多数患者症状都会改善。治疗通常从简单的生活方式调整和膀胱训练开始，必要时才逐步升级。每个步骤可能需要几周才能见效，请给每一步足够的时间，并与医疗团队保持沟通，找到适合您的方案。

如何诊断

- 询问症状并填写**膀胱日记**
- **尿液检测**以排除感染或血尿
- 检查膀胱排空情况（快速膀胱扫描）
- 如诊断不明确或既往治疗无效，有时需进一步检查（尿动力学检查或膀胱镜检查）

如何治疗（分步进行）

- 1 生活方式调整与训练** — 减少咖啡因和酒精摄入，合理控制饮水，治疗便秘，减轻体重，并进行**膀胱训练**和**盆底肌锻炼**。
- 2 药物治疗** — 口服药物以抑制膀胱肌肉过度收缩。
- 3 进阶治疗** — 膀胱内注射**肉毒毒素（Botox）**，或**神经电刺激**（PTNS或骶神经调控）。每种方法均有专属患者须知。

日常管理

- 坚持记录**膀胱日记**几天，找出诱发因素。
- 均匀补充水分；不要过度限制饮水，以免尿液过于浓缩。
- 按照医疗团队指导，采用**定时如厕**和“尿急控制”技巧（停下来、收缩盆底肌、深呼吸，再去厕所）。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 排尿时出现**血尿**，或疼痛、烧灼感
- 发热，或背部、侧腰疼痛（可能为感染）
- **突然无法排尿**

需要记住的三件事

- 1. OAB的症状**——尿急、尿频、夜间如厕，有时伴有漏尿——十分常见且可以治疗，并非衰老的正常现象。
- 2. 治疗循序渐进**：先从生活方式调整和膀胱训练开始，再考虑药物，之后才是肉毒毒素或神经电刺激。
- 3. 膀胱日记**有助于发现诱因；每个步骤需要几周时间。出现血尿、疼痛、发热或无法排尿时，请及时联系医疗团队。